

NS E5423410 254

MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA

IDADE:	PESO:	ALTURA:	PROFISSÃO:
SINTOMAS: <i>Sondulúcia / Dor nas pernas / Refluxo / Dor nas</i>			
QUEIXAS: <i>pernas edema / alergia pelo corpo todo.</i>			
MEDICAMENTOS: <i>Propalolol / Melatonina / Sertralina</i>			
<i>HAS / Colesterol / Artrite / Depressão / DPOC / Bronquite</i>			
MÉDICO: <i>Drº Yuri - Drº</i>			
EXERCÍCIO FÍSICO: <i>não faz</i>			
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: <i>S</i>		ALMOÇO: <i>S</i>	LANCHE: <i>S</i> JANTAR: <i>S/N</i>
HORA QUE DORME: <i>21hs</i>		HORA QUE ACORDA: <i>10hs</i>	
COCHILO () SIM () NÃO		DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () NÃO NA SEMANA () NÃO			
FUMO () SIM () NÃO / DIA () NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:			
TIPO DE RESPIRAÇÃO:		BANHEIRO:	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: <i>globosa</i>		CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: <i>híper</i>	MALLAMPATI: <i>IV</i>	IAH: <i>40,8</i>	SPO2: <i>73%</i>
PATOLOGIAS ASSOCIADAS:			
CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA			
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: <i>—</i>			
COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA			
() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS <i>Bronquite / 6x PNM</i>			
<i>max. Swift FX</i>			
<i>CPAP Auto BMC</i>			
<i>22-02 - Adaptação</i>			
<i>24</i>			
<i>27/02/24 P= 4,0 cmH₂O P95%: 4,4 cmH₂O</i>			
<i>IAH= 1,8 e/h</i>			
<i>fuga= 9 l/min</i>			
<i>m. de uso= 4h40</i>			
<i>↓ P: 4 à 8 cmH₂O</i>			
<i>Ajuste másc</i>			
<i>08/03 P= 4-8 cmH₂O P95%:</i>			
<i>24 IAH= 1,3 e/h</i>			
<i>m. de uso: 5,30hrs.</i>			
<i>fuga=</i>			
<i>10/04 P= 5,1 cmH₂O</i>			
<i>24 IAH= 1,5 e/h</i>			
<i>m. de uso: 6hrs</i>			
<i>Fuga= 4,9 lpm.</i>			
<i>24/09/24 P= 4 cmH₂O</i>			
<i>IAH= 1,4 e/h</i>			
<i>m. de uso: 1h23'</i>			
<i>Total dias de uso: 30 dias / 30 dias</i>			
<i>Não se adaptou bem a máscara</i>			
<i>Swift e a máscara da filha</i>			
<i>falta paci</i>			
<i>Natália</i>			

19/12 P= 5,5cmH₂O
24 IAH = 2.3e1ev
m. de uso = 4h44'

lua cláudio

10/04 P= 5,5cmH₂O
25 m. de uso: 6h30'
Bem adaptada.

troco o filtro da mãe.
e fixador cefálico lua

Nome: MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA

Peso: 65 kg

Data de Nascimento: 15-9-1948

Altura: 1,45 m

IMC: 30,92

Médico: DR. YURI DE OLIVEIRA

Sexo: Feminino

Medicamentos:

Data do exame: 16-07-2022

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 16-07-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 510,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 35,5 e 132,5 minutos. O tempo total de sono foi de 401,5, eficiência de 78,7% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,6%; estágio N2: 60,6%; estágio N3: 21,5%; sono REM: 16,2%. O índice de despertares foi de 26,2/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 40,8/hora, sendo elas 39 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 167 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e mínima de 73%, permanecendo 4,1% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 54 - 75 bpm e NREM de 55 - 79 bpm.

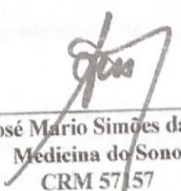
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (01), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 40,8/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=73%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. presença de atividade em EMG de queixo;
8. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (7,8/hora);
9. registro de ronco durante o sono.

**Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.
Presença de bruxismo.**

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.157